

Ya, Anda benar. Dalam basis pengetahuan Anda, memang terdapat kasus di mana **beberapa gejala memiliki bobot CF tertinggi yang sama** (misalnya, Insomnia memiliki tiga gejala dengan bobot 0.95)¹¹¹. Ini justru **sangat menguntungkan** dalam merancang aturan selektif, karena memberikan lebih banyak opsi untuk memicu *forward chaining*.

Kita akan menggunakan gejala-gejala berbobot tertinggi yang sama ini sebagai **kondisi pemicu terkuat** (*Strongest Trigger*).

Berikut adalah draf **Aturan Inferensi Berbasis Pohon Keputusan** yang telah disesuaikan, menggunakan semua gejala kunci (CF ≥ 0.90) sebagai pemicu untuk transisi (*Set Gejala Konfirmasi*).

Fase I

Rule ID	Kondisi Pemicu Terkuat (IF User answers "Ya" on...)	Aksi (THEN...)	Set Gejala Konfirmasi (Tampilkan Sisa Gejala dengan CF ≥ 0.90)
R.P1	G01 (0.95) ATAU G02 (0.95) ATAU G03 (0.95) 121212	Prioritaskan Insomnia.	Tampilkan: G04 (0.90) dan G11 (0.90) ¹³
R.P2	G12 (1.0) ATAU G13 (0.95) ATAU G14 (0.95) ATAU G15 (0.95) ¹⁴	Prioritaskan Obstructive Sleep Apnea (OSA).	Tampilkan: G2 (0.90) dan G19 (0.90) ¹⁵
R.P3	G23 (0.95) ATAU G24 (0.95) ATAU G25 (0.95) 16	Prioritaskan Hipersomnia.	Tampilkan: G11 (0.95), G32 (0.90), G26 (0.90), dan G27 (0.90) ¹⁷
R.P4	G35 (0.95) ATAU G37 (0.90) ATAU G36 (0.90) ATAU G38 (0.90) ¹⁸	Prioritaskan Sleepwalking.	Tidak ada sisa gejala ≥ 0.90. Lanjut ke Fase III.
R.P5	G42 (0.95) ATAU G43 (0.95) ATAU G44 (0.90) 19	Prioritaskan Ritme Sirkadian.	Tampilkan: G45 (0.90) ²⁰

Fase II: Opsi Pertanyaan Tambahan (Sisa Gejala)

- **Opsional:** Setelah Fase I selesai, Anda bisa menampilkan **set gejala umum** (bobot \$0.70 - 0.85\$) yang dimiliki oleh **lebih dari satu penyakit** (misalnya G05, G06, G11, G16, G5, G6) untuk mendapatkan bukti tambahan, atau langsung ke Perhitungan.
- **Perhitungan:** Lakukan perhitungan **VCIRS dan Certainty Factor** untuk semua 5 penyakit. Semua gejala yang tidak ditampilkan atau dijawab "Tidak" memiliki $SCF[E]=0\$$.

Keuntungan Logika Ini:

1. **Maksimal 10 Pertanyaan untuk 1 Penyakit:** Jika pengguna kuat mengarah ke Insomnia (R.P1 terpicu), total pertanyaan yang diajukan hanya 5 (Fase I) + 2 (Fase II) + (Opsional Tambahan) = **sekitar 7-10 pertanyaan**, jauh di bawah 47.
2. **Memanfaatkan Kesamaan Bobot:** Aturan pemicu (misalnya, R.P2: G12, G13, G14, G15) menggunakan semua gejala dengan bobot tertinggi yang sama, sehingga meningkatkan peluang sistem untuk dengan cepat memprioritaskan penyakit yang benar.
3. **Memisahkan Fungsi:** Logika *forward chaining* ini hanya mengatur antarmuka, sementara metode VCIRS/CF yang berat tetap bertugas menghitung akurasi diagnosis di *backend*.